DOSSIER: Zorg, Welzijn, Sport

1. Verkiezingsprogramma (Zie bijlage)

- we bundelen en versterken bestaande wijkvoorzieningen tot één herkenbaar en krachtig wijkloket per buurt, en maken een heldere visie op de zorg- en welzijnsbehoeften per wijk
- professionalisering wijkteams met betere triage en voldoende budget voor bemensing
- beter vestigingsklimaat voor zorgprofessionals
- We schakelen over op langdurige, planmatige subsidierelaties met zorg en welzijn
- Opbouwwerkers terug in de wijken, voor vroegtijdig signaleren sociale problemen en zorgzame wijken
- Sport betaalbaar maken, oa door de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen te intensiveren
- Stimuleren gezond aanbod, beperken van fastfood
- Minimaregelingen voor gezonde voeding
- We gaan in gesprek met zorgverleners, zorgverzekeraars en andere partners om toegang tot tandzorg beter te regelen
- Seksuele gezondheidszorg: meer gratis en anonieme soa-tests via de GGD's, meer budget via GGD, publiekscampagnes, gratis menstruatieproducten
- Gezonde basisschool van de toekomst
- Jeugdzorg:
    - Deel van het jeugdzorgbudget naar de jeugdgezondheidszorg om problemen te voorkomen in plaats van te repareren
    - Veendam model: regie jeugdhulp bij gemeente en minder markt
    - Geld voor POH jeugd bij huisartsenpraktijken; voor innovatiebudget; betere crisisopvang voor jongeren
- Versnellen ombouw gesloten jeugdzorg
- Ouderen- en mantelzorg: wijkverpleging centraal, uitbreiding Rotterdampas, steun mantelzorgers, impuls respijtzorg, digitale hulppunten, cultuursensitieve dagbesteding, betere acute opvang
- We reserveren bouwlocaties voor kleinschalige woonzorginitiatieven en breiden wijkgerichte thuiszorg teams uit
- We leggen meerjarige contracten vast met hospices en thuiszorgorganisaties voor terminale zorg
- Rotterdamse "GGZ-Herstelalliantie": Eén regioplan, wachttijden verlagen, meer GGZ-teams in de wijk
- Inloopvoorzieningen weer terug
- Structurele GGZ-politiealliantie voor humane opvang bij onbegrepen gedrag: vast budget voor een Integrale Straattriagedienst
- Welzijn: Betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen informele organisaties en de gemeente.
- bestaande voorrangsregeling huisvesting maatschappelijke beroepen uitbreiden naar alle schaarse zorg- en welzijnsfuncties.

STEMBUSAKKOORD SOCIALE BASIS

2. Top 3 Prioriteiten

Omschrijf per prioriteit, gerangschikt van 1-3 in onderhandelingswaarde:

I. Prioriteit 1

- **Jeugd en jongeren (meer preventie, minder jeugdzorg)**
- Maatschappelijke effecten:
    - De GRJR (jeugdzorg regio Rotterdam) loopt tegen grote knelpunten aan. Het is wethouder Buijt niet gelukt hier grip op te krijgen. Volgens ons kan dit maar op 1 manier: preventie vanuit de wijken, ingrijpen dichtbij voordat dure specialistische zorg nodig is. Inspiratie: Veendam model.
    - Als we dit *niet* regelen: zorgkosten blijven stijgen, wachtlijsten blijven te lang (vooral bij kleine hulpvragen voor jongste kinderen, problemen worden te laat gesignaleerd)
    - Als we dit *wel* regelen: problemen worden opgelost voor ze uit de hand lopen, zorgkosten onder controle, kinderen kunnen langer thuis / in eigen wijk blijven, gezinnen worden ingebed in groter hulpnetwerk, gezinsgerichte hulp dichtbij.
- **Wezenlijk punt.**
- Of dit om een structurele en/of incidentele investering vraagt: **structureel**.
- Aandachtspunten voor de uitvoering op capaciteit en dienstverlening.

II. Prioriteit 2

- **Sociale initiatieven structureel financieren**
- Zie akkoord sociale basis
- Maatschappelijke effecten:
    - Als we dit *niet* regelen: terwijl landelijk op zorg wordt bezuinigd zal op de sociale basis alleen maar meer aanspraak gemaakt worden. Initiatieven die de afgelopen jaren minder geld hebben gekregen lopen het risico om te vallen, mensen raken dan hun vertrouwde plekken kwijt. Denk aan buurtclubs, inloopvoorzieningen, sportverenigingen, en andere organisaties.
    - Als we dit *wel* regelen: geeft kleine en middelgrote initiatieven bestaanszekerheid en de kans om te kunnen groeien. Zorgt voor meer vertrouwen en vaste gezichten voor kwetsbare Rotterdammers. Geeft initiatieven de kans lange-termijn plannen te maken. Zie Ombudsman (aanbeveling over plekken van waarde).
- Of dit een wezenlijk of symbolisch punt betreft: **wezenlijk punt.**
- Of dit om een structurele en/of incidentele investering vraagt: **structureel**.
- Aandachtspunten voor de uitvoering op capaciteit en dienstverlening: haal in wijkraden eerst input op over de plekken van waarde, zorg voor inspraak.

III. Prioriteit 3

- **Volkstuinen huurprijs omlaag? Sportdeelname vergroten?**
- Maatschappelijke effecten:
    - Als we dit *niet* regelen:
    - Als we dit *wel* regelen:
- Of dit een wezenlijk of symbolisch punt betreft:
- Of dit om een structurele en/of incidentele investering vraagt:
- Aandachtspunten voor de uitvoering op capaciteit en dienstverlening:

Aandachtspunt: wachttijd WMO terugbrengen tot wettelijke termijn. Bezuiniging huishoudelijke hulp + eigen bijdrage abonnementstarief uitzoeken / hierin meenemen

3. Standpunten andere partijen

Benoem per partij (D66, VVD, CDA, Leefbaar, DENK):

- Hun beleidsprioriteiten
- Welke van onze prioriteiten liggen gevoelig?
- Welke van hun prioriteiten zijn voor ons gevoelig? (bijv. asielstop)

D66

-Jeugdzorg en WMO: nadruk op inclusieve zorg (LHBTQ+), transkliniek (willen wij ook). Ze willen alles efficiënter en vereenvoudigen dmv technologie (E-health) en oa administratieve lasten verminderen.
-Investeren in sport: sportstroken, hubs, sportfonds volwassenen, Erasmus sport. KNVB campus naar Rotterdam halen.

VVD

-Zorgbudgetbeheersing: Zorgkosten moeten betaald worden met zorggeld. Overschrijdingen moeten binnen het huidige zorgbudget worden opgevangen, waarbij het zorgbudget niet mag groeien. Investeren in vroege signalering.
-Gezinsgerichte aanpak, Preventie is essentieel. Aanpak van wachttijden door procedures te versimpelen en in te zetten op bewezen effectieve hulp.
-WMO en Wijkteams: WMO moet eerlijk, doelmatig en begrijpelijk zijn, en alleen voor wie het echt nodig heeft. Investeren in de deskundigheid van wijkteams voor betere beoordeling, doorverwijzing en ondersteuning.
-Kwetsbare Rotterdammers: Aandacht voor het doorbreken van eenzaamheid, met name bij ouderen, jongeren en mensen met een beperking (via ontmoetingsplekken en wijkactiviteiten).

CDA

-Brede aanpak jeugdhulp waarbij niet alle hulp aan kinderen en jongeren direct via jeugdzorg hoeft te lopen. We stoppen met overmedicaliseren van problemen bij het opgroeien. Wijkteams meer ruimte om budget in te zetten met en via informele netwerken. Investeren in maatschappelijk voorveld, administratieve drempels weghalen, verbindingen leggen.

-Doelgroepenvervoer: niet systeem veranderen maar wel investeren in betere samenwerking aanbieders, klanten en gemeente.
-We zorgen voor een informatie- en hulppunt in de wijken: Zorgverleners, welzijnswerkers, woningcorporaties en informele zorgpartijen werken daar samen. Het maatwerkbudget van wijkteams moet fors worden verhoogd toegankelijkheid mondzorg verbeteren

Leefbaar

DENK

Bronnen: verkiezingsprogramma, stemwijzer, stemgedrag in de raad (maar let op coalitie-oppositie)

4. Huidige Coalitiebeleid

- Doorzetten:
  - Wijkteams: minder administratiedruk en meer professionele vrijheid voor de medewerkers. https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2025/09/RO2403-opvolgingsonderzoek-wijkteams.pdf
- Aanpassen:
  - Doelgroepenvervoer zelf organiseren, weg van aanbestedingen. (https://orr.nl/brief-aan-de-rotterdamse-gemeenteraad-maatwerk-bij-doelgroepenvervoer/)
  - Zwembad Overschie heropenen?
  - LekkerFit weer in ere herstellen?
- Stoppen: -
- Voor welk beleid stopt na 2026 de financiering? Is dat prima zo of moet er structurele dekking komen?

2.2 ZORG EN WELZIJN

Goede zorg is geen voorrecht maar een basisrecht. Toch ervaren veel Rotterdammers zorg als een doolhof van loketten, formulieren en wachtlijsten. Als toegang te ingewikkeld is, groeit wantrouwen naar instellingen en de gemeente. GroenLinks-PvdA draait dat om: wij bouwen aan zorg die dichtbij, duidelijk en betrouwbaar is.

We beginnen in de wijk. Samen met partners maken we per wijk een plan dat de lokale behoeften vastlegt en richting geeft voor de toekomst. Geen anonieme loketten, maar kleine, herkenbare teams op vertrouwde plekken: buurthuis, huisarts, school en bibliotheek. Wie hulp nodig heeft, krijgt één aanspreekpunt dat meedenkt en meedoet. Tegelijk werven, leiden en behouden we zorgprofessionals, zodat elk wijkplan wordt gedragen door genoeg vakmensen.

Preventie is leidend. Vroeg signaleren voorkomt zwaardere, duurdere trajecten. Investeren in basiszorg en preventie verdient zich terug in gezondheid en menskracht.

Net als bij de stadsvernieuwing kiezen we voor sociale vernieuwing in de zorg: gerichte investeringen in mens, ruimte en samenwerking. Het Rijk hoort mee te investeren; Rotterdam wacht niet en pakt door.

We bouwen op de kracht van meer dan zeshonderd informele welzijnsorganisaties. Deze warme, laagdrempelige netwerken staan als eerste naast bewoners en blijven als veilige nazorg aanwezig wanneer formele hulp afschaalt. Door hun financiering structureel te maken, voorkomen we escalatie en behouden we het vertrouwen dat zij al hebben opgebouwd.

Zorg is pas geslaagd wanneer iedereen weet waar zij terecht kunnen, professionals met plezier hun vak uitoefenen en wijken sterker worden omdat gezondheid en welzijn dicht bij huis zijn georganiseerd. Zo maken we van Rotterdam een stad waar zorg voelbaar is voordat het te laat is en waar iedere inwoner gezond, veerkrachtig en volwaardig kan meedoen.

WIJKTEAMS, VRAAGWIJZER & BUURTLOKETTEN

Wijkplan Zorg en Welzijn: We zorgen voor verbinding tussen formele en informele organisaties in relatie tot de zorginstellingen, politie, scholen, maatschappelijke organisaties, gemeente en de wijkraad. Een netwerk dat naar boven haalt wat nodig is vanuit wijken en buurten. We zetten in op de vraag vanuit de wijk met erkenning dat niet in iedere wijk hetzelfde aan de orde is of wordt gevraagd. Vervolgens maken we een heldere visie op de lokale zorg- en welzijnsbehoeften en definiëren we concrete actielijnen voor zowel preventieve signalering (via bijvoorbeeld scholen of mentorprojecten) als acute hulpverlening, zodat elke wijk een veerkrachtige en op maat gemaakte zorgbasis krijgt.

Eén wijkloket per buurt: We bundelen en versterken bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld wijkhubs, Huizen van de Wijk etc) tot één herkenbaar en krachtig wijkloket per buurt, waarin zowel het wijkteam als de Vraagwijzer op een vaste, goed vindbare locatie samenwerken.

Vaste spreekdagen op vertrouwde plekken: Wijkteams en Vraagwijzer zijn wekelijks ook aanwezig in huisartsenpraktijken, buurthuizen, scholen en bibliotheken, zodat alle bewoners snel de weg naar ondersteuning vinden.

Investeren in professionalisering: We zorgen voor gerichte scholing en professionalisering van de wijkteams. We doen onderzoek naar betere triagemethoden, én maken voldoende budget vrij voor bemensing van de wijkteams.

Vestigingsklimaat voor zorgprofessionals: In elke wijk creëren we een gunstig klimaat voor huisartsen en andere professionals (inclusief praktijkruimte).

Langdurige subsidierelaties: We schakelen over op langdurige, planmatige subsidierelaties met ingebouwde toets- en bijstelmomenten en dringen we marktwerking in de zorg radicaal terug. Dit betekent onder meer dat we waar wettelijk mogelijk van periodieke aanbestedingen voor het wijkwelzijnswerk terugkeren naar vaste relaties met daarin gespecialiseerde instellingen.

GEZONDE ROTTERDAMMERS: PREVENTIE, SPORT, BEWEEGOMGEVING EN VOEDING

Opbouwwerkers terug in de wijk: Samen met zorg- en welzijnsorganisaties zorgen we dat Rotterdam weer voldoende opbouwwerkers in de wijken heeft. Zij spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van sociale problemen. Opbouwwerkers ondersteunen bewoners direct en hebben een belangrijke rol in het versterken van sociale netwerken waardoor een wijk als geheel zorgzamer wordt.

Sportdeelname voor iedereen: De gemeente biedt structurele, duurzame steun aan inwoners met een inkomen onder modaal om deel te nemen aan sportactiviteiten. We versterken de ondersteuning van lokale sport- en welzijnsorganisaties zoals sportfondsen. Hier betrekken we ook de zorgverzekeraars om dit mogelijk te maken.

Scholen-sportverenigingen intensiveren: We intensiveren de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen, zodat alle basisschoolleerlingen structureel kans krijgen om aan sport deel te nemen en plezier te beleven aan bewegen.

Vrouwvriendelijke wijkzorg: Wij zetten ons in voor meer aandacht voor vrouwengezondheid. We onderschrijven en ondersteunen het onderzoek van instituten als het Erasmus MC en stimuleren samenwerking met eerstelijns zorgverleners.

Rookvrije generatie: Om een rookvrije generatie te bevorderen, voorkomen we dat jongeren beginnen met roken en maken we overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen en sportvelden voortaan rookvrij.

Stimuleren gezond aanbod, beperken van fastfood: We stellen een nieuwe verordening in om het aantal fastfoodvestigingen te beperken, terwijl gezonde, duurzame en betaalbare eetgelegenheden en winkels juist verruimde vestigingsmogelijkheden krijgen.

Minimaregelingen voor gezonde voeding: Minimaregelingen worden uitgebreid zodat alle Rotterdammers toegang hebben tot gezonde voeding en essentiële voedingssupplementen, en werkgevers worden aangemoedigd gezonde bedrijfskantines en vergoedingsregelingen te faciliteren.

Betaalbare mondzorg voor iedereen: We geven extra aandacht aan de toegankelijkheid van tandzorg. We gaan in gesprek met zorgverleners, zorgverzekeraars en andere partners om ervoor te zorgen dat toegang tot tandzorg voor Rotterdammers beter geregeld wordt.

Een veilige en goede seksuele gezondheid: We versoepelen de criteria voor gratis en anonieme soa-tests via de GGD's en verminderen daarmee de werkdruk voor de huisartsen. We verruimen het budget voor aanvullende seksuele gezondheidszorg-capaciteit bij de GGD. We herintroduceren grote publiekscampagnes om jongeren en anderen voor te lichten over prettige en veilige seks. Menstruatieproducten gaan we gratis aanbieden op scholen en in overheidsgebouwen.

Weg met zorgcowboys: Er zijn private partijen die zonder de juiste papieren en diploma's 'zorg' aanbieden aan Rotterdammers en hier torenhoge prijzen voor durven te vragen. We stellen hier paal en perk aan. Zorg moet professioneel en betaalbaar zijn.

Gezonde basisschool van de toekomst: Rotterdam introduceert de gezonde basisschool van de toekomst, naar voorbeeld van het lopende programma in Limburg. Op deze scholen is 'gezond eten en bewegen' een vanzelfsprekend onderdeel van de schooldag. Een gezonde toekomst begint immers bij de jeugd.

JEUGDZORG & JEUGD-GGZ

Investeer in jeugdgezondheidszorg om jeugdzorg te voorkomen: We zullen een deel van het jeugdzorgbudget naar de jeugdgezondheidszorg besteden om problemen te voorkomen in plaats van te repareren. Dit doen we door bijvoorbeeld in te zetten op een gezinsgerichte benadering en betere samenwerking met scholen. Dat levert gezondere kinderen op én minder dure jeugdzorg.

Jeugdhulp terug in gemeentelijke regie: In Veendam verdwenen de wachtlijsten toen de gemeente de regie terugnam en de marktwerking verminderde. Dat inspireert ons: ook in Rotterdam willen we de jeugdhulp organiseren met minder aanbieders, meer samenwerking en professionals dicht bij de scholen en de huisartsen. We zorgen er hiermee voor dat kinderen en hun (pleeg)ouders makkelijker hun weg kunnen vinden in het jeugdzorgsysteem, waardoor ze sneller bij passende hulpverlening terecht kunnen komen. Zo voorkomen we ook dat problemen onnodig escaleren.

Vaste gezichten en langdurige betrokkenheid: We kiezen voor vaste gezichten en langdurige betrokkenheid in de jeugdzorg.

POH-jeugd in huisartsenpraktijk: De Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin wordt uitgebreid in de huisartsenpraktijken, met korte lijnen naar wijkteams en directe toegang tot jeugd-ggz. De gemeente zal hiervoor budgetten beschikbaar stellen.

OUDERENZORG & MANTELZORG

Wijkverpleging centraal: Rotterdam probeert voldoende en toegankelijke wijkverpleging als spil in de wijk voor de zorg te regelen. Dit doen we samen met de zorginstellingen.

Uitbreiding RotterdamPas: De RotterdamPas wordt uitgebreid met een breder aanbod van sport- en ontmoetingsactiviteiten, speciaal voor ouderen, zoals 50+-zwemlessen, in samenwerking met sportscholen en andere organisaties in de stad.

Ondersteuning mantelzorgers: Mantelzorgers krijgen goede ondersteuning. Door goede samenwerking met de zorgverzekeraars, aanbieders van zorg en welzijn en scholen bereikt de ondersteuning ook de mantelzorgers die minder snel om hulp vragen, zoals jongeren of mensen met een migratieachtergrond. De gemeente steunt organisaties die mantelzorgers bijstaan.

Impuls voor respijtzorg: We geven een impuls aan respijtzorg voor mantelzorgers door het aanbod proactief, cultuursensitief en tijdig beschikbaar te maken.

Digitale hulppunten: In bibliotheken en buurthuizen komen digitale hulppunten waar ouderen veilig leren omgaan met computers, internet en digitale diensten.

Cultuursensitieve dagbesteding: Vrijwilligers en professionals bieden zinvolle dagbesteding en een cultuursensitief aanbod voor ouderen.

Acute opvang bij crisis: Op dit moment is de acute opvang van ouderen in Rotterdam onduidelijk en traag, met onbedoelde frustratie bij zorgverleners en naasten. Daarom ontwikkelen we in samenwerking met zorginstellingen en welzijnsorganisaties een integraal opvangplan met kleinschalige crisislocaties en heldere procedures, zodat ouderen snel en menselijk worden ontvangen en direct de juiste zorg krijgen.

Ouderenzorg versterken: Samen met verpleeghuizen, huisartsen en onderwijsinstellingen investeert de gemeente in meer zorgpersoneel gespecialiseerd in ouderengeneeskunde (denk aan wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, enz.). Zo zorgen we dat ouderen in Rotterdam toegang houden tot passende zorg dichtbij huis.

Passende zorg en woonplekken voor ouderen in elke levensfase: We zorgen voor zowel intramurale (verpleeghuis- en woonzorgcomplexen) als extramurale voorzieningen binnen redelijke reistijd. We zetten in op een nieuwe woonzorgvisie voor senioren, hierbij reserveren we bouwlocaties voor kleinschalige woonzorginitiatieven en breiden we wijkgerichte thuiszorgteams uit.

Zorg in laatste levensfase: We leggen meerjarige contracten vast met hospices en thuiszorgorganisaties voor terminale zorg. Zo is er altijd een geschikte plek of zorg aan huis beschikbaar, óók in de laatste levensfase.

PSYCHISCHE GEZONDHEID

Rotterdamse "GGZ-Herstelalliantie": Eén regioplan, wachttijden verlagen, meer GGZ-teams in de wijk: De geestelijke gezondheidszorg is nu versnipperd. Zorgverzekeraars regelen de behandeling van volwassenen, de gemeente die van jeugd, de politie bewaakt de veiligheid en GGZ-instellingen voeren de zorg uit. Door die opdeling vallen te veel mensen tussen wal en schip. Rotterdam pakt de regie en smeedt een publiek-private Herstelalliantie waarin verzekeraars, huisartsen, cliëntenorganisaties en alle grote GGZ-aanbieders samenwerken. Op basis van de aanbevelingen uit de IGJ/NZa-rapportage komt er één integraal Regioplan Geestelijke Gezondheidszorg met harde prestatieafspraken. We zetten ook in op kortere wachttijden, meer wijk-GGZ en passende bemoeizorg. We zullen tevens een regionaal loket voor complexe casuïstiek oprichten, zodat men sneller en beter de juiste zorg en opvang kan krijgen.

Inloopvoorzieningen weer terug: GGZ-inloopvoorzieningen worden in ere hersteld.

Toegankelijke GGZ: De gemeente gaat verschillende instellingen actief faciliteren om wachtlijsten te verminderen.

Stigmabestrijding en dialoog: We bestrijden stigma rond psychische problemen actief en bevorderen open dialoog via voorlichtingscampagnes en evenementen.

Structurele GGZ-politiealliantie voor humane opvang bij onbegrepen gedrag: De gemeente reserveert jaarlijks een vast budget voor een Integrale Straattriagedienst: een 24/7-team van speciaal getrainde GGZ-professionals en politieagenten dat beschikbaar is bij meldingen van onbegrepen of verward gedrag. Het team voert tijdig deskundige triage uit, verleent eerste psychosociale zorg en regelt een warme overdracht naar passende opvang of behandeling. Zo krijgen mensen die hulp nodig hebben snel de juiste ondersteuning, worden escalaties voorkomen en neemt de overlast voor omwonenden merkbaar af.

INFORMELE ORGANISATIES, WELZIJN EN WMO

Laagdrempelige cliëntenondersteuning: Bij elk wijkloket is extra ondersteuning beschikbaar voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, laaggeletterd of onvoldoende taalvaardig.

Duurzame financiering en fonds: We versterken informele welzijnsorganisaties met train-de-trainer-programma's, zakelijke ondersteuning en een publiek-privaat fonds voor meerjarige financiering, zodat deze organisaties duurzaam kunnen samenwerken met de gemeente.

Vaste aanspreekpunten: Door vaste aanspreekpunten en duidelijke afspraken verbeteren we de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen informele organisaties en de gemeente.

Inclusieve participatietafels: We faciliteren wijk-Wmo-tafels waarin cliënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en de gemeente samen knelpunten signaleren en oplossingen uitproberen, met beslisbevoegdheid voor kleine budgetten.

Reguliere evaluatie en transparantie: We zetten in op jaarlijkse publicatie van Wmo-prestatie-indicatoren (doorlooptijden, klanttevredenheid, aantal maatwerkvoorzieningen) en wijkrapportages, gekoppeld aan bijsturingsmaatregelen. De gemiddelde Wmo-afhandeltermijn ligt helaas ver boven de 42 dagen. Een taskforce met wijkteam-, Vraagwijzer- en backofficecapaciteit zet een hard maximum van 30 dagen.

Betrouwbare data en open monitoring: Het is op dit moment onmogelijk voor Rotterdammers om zicht te hebben op de cijfers rondom de Wmo. We bouwen een open-datadashboard waarin Wmo-, wijkteam- en jeugdhulpcijfers inzichtelijker worden.

MEER ZORG- EN WELZIJNSPERSONEEL AANTREKKEN

We maken wonen betaalbaar en dichtbij het werk: We zullen de bestaande voorrangsregeling huisvesting maatschappelijke beroepen uitbreiden naar alle schaarse zorg- en welzijnsfuncties.

We reserveren in nieuwbouwprojecten een vast aandeel betaalbare huur- en "short-stay"-woningen voor (aankomende) zorgmedewerkers: Bij nieuwbouwplannen van zorgorganisaties, zoals bouwen van verpleeghuizen, kan een bepaald percentage van de gebouwen voor zorgmedewerkers worden gealloceerd als woningen. Veel zorgorganisaties hebben al goede initiatieven om hun personeel aan een woning te helpen. We bundelen deze initiatieven rond meer woningen voor zorgverleners en brengen de huidige regelingen onder de aandacht.

Regionaal Zorgwerkgeverschap Rotterdam-Rijnmond: We creëren samen met zorgaanbieders een regionaal centrum met een gedeelde flexpool, gelijke beloning voor gelijk werk en een regionale aanpak van zzp-inzet. Dit vergroot baanzekerheid, maakt overstappen tussen organisaties makkelijker, houdt professionals voor de regio behouden en zorgt voor minder ongezonde concurrentie tussen zorgorganisaties. We geven hierbij ook loopbaanadviezen, sollicitatietrainingen en matching van personeel aan vacatures in samenwerking met zorgorganisaties.

Versnel leren op de werkvloer: We investeren extra in leerwerkplaatsen voor zij-instromers om te zorgen dat zij makkelijker voor zorg zullen kiezen (mbo, hbo en niveau-2-instaptrajecten).

Ontlast professionals: minder rompslomp, meer veiligheid: We gaan sterk inzetten op verbetering van digitale triage- en dossiersystemen die administratieve lasten verlagen. We gaan onderzoeken of we in de regio Rijnmond een digitaal doorverwijs- en triagesysteem kunnen inzetten om verwijzingen tussen huisartsen, GGZ en wijkteams beter te stroomlijnen en administratielasten te verlagen.